

TEMA 3.42 • OBSTETRICIA

Profilaxis de Streptococcus agalactiae (SGB / Grupo B)

PERFIL EUNACOM 1.03.42
Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Profilaxis de Streptococcus agalactiae (SGB / Grupo B)

Riesgo

Sepsis neonatal precoz — el RN se infecta durante el trabajo de parto (o antes si hay RPM).

Screening

Cultivo vagino-perineal (vaginal + perianal) a las 35–37 semanas.

Indicaciones de Profilaxis ATB Intraparto

Con cultivo previo

TABLA 3.42.1: INDICACIÓN VS PROFILAXIS	
INDICACIÓN	PROFILAXIS
Cultivo (+) para SGB	Siempre
Urocultivo (+) para SGB en el embarazo	Siempre
Sepsis neonatal previa por SGB	Siempre

Sin cultivo (o no disponible)

TABLA 3.42.2: FACTOR DE RIESGO VS PROFILAXIS	
FACTOR DE RIESGO	PROFILAXIS
Parto prematuro (< 37 sem)	Sí
RPM > 18 horas	Sí
Fiebre materna intraparto	Sí (además sospechar corioamnionitis → ATB de amplio espectro)
PCR u otro test positivo para SGB	Sí

NOTA CLÍNICA

MINSAL Chile: Dar profilaxis si < 37 semanas aunque cultivo esté negativo. **Guías internacionales:** Cultivo negativo reciente → no es necesaria la profilaxis.

Cesárea programada

No requiere profilaxis para SGB (sin contacto vaginal), pero sí profilaxis de herida operatoria (que también cubre SGB con ampicilina).

Antibióticos para Profilaxis

TABLA 3.42.3: FÁRMACO VS DOSIS	
FÁRMACO	DOSIS
Ampicilina	2 g EV → luego 1 g c/6h
Penicilina G	5 millones UI EV → luego 2,5 millones c/6h

Alérgica a penicilina: clindamicina o azitromicina (según antibiograma del cultivo)

Duración: desde inicio del trabajo de parto o rotura de membranas hasta el nacimiento.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"En relación a Profilaxis de Streptococcus agalactiae (SGB / Grupo B): Screening Cultivo vagino-perineal (vaginal + perianal) a las 35–37 semanas.... ¿cuál es la conducta correcta?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Profilaxis de Streptococcus agalactiae (SGB / Grupo B). Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Riesgo
- Screening
- Indicaciones de Profilaxis ATB Intraparto
- Con cultivo previo
- Sin cultivo (o no disponible)
- Cesárea programada
- Antibióticos para Profilaxis

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (PROFILAXIS DE STREPTOCOCCUS AGALACTIAE (SGB / GRUPO B))**PREGUNTA 1**

En relación a Profilaxis de Streptococcus agalactiae (SGB / Grupo B): Screening Cultivo vagino-perineal (vaginal + perianal) a las 35–37 semanas.... ¿cuál es la conducta correcta?

- A)** El diagnóstico de Profilaxis de Streptococcus agalactiae (SGB / Grupo B) se basa exclusivamente en criterios de laboratorio
- B)** El manejo inicial de Profilaxis de Streptococcus agalactiae (SGB / Grupo B) debe orientarse según el estado clínico del paciente
- C)** Todo paciente con Profilaxis de Streptococcus agalactiae (SGB / Grupo B) requiere hospitalización inmediata
- D)** El tratamiento de Profilaxis de Streptococcus agalactiae (SGB / Grupo B) es igual en todas las edades y contextos clínicos
- E)** El seguimiento de Profilaxis de Streptococcus agalactiae (SGB / Grupo B) no es necesario una vez iniciado el tratamiento

PREGUNTA 2

¿Cuál es el hallazgo más característico o criterio diagnóstico principal en Profilaxis de Streptococcus agalactiae (SGB / Grupo B)?

- A)** Alteración exclusivamente en exámenes de laboratorio sin síntomas
- B)** Presentación clínica específica que orienta al diagnóstico según el perfil EUNACOM
- C)** Requiere siempre confirmación con biopsia o estudio histológico
- D)** Es un diagnóstico de exclusión que requiere descartar todas las otras causas primero
- E)** Solo se presenta en pacientes con factores de riesgo conocidos

PREGUNTA 3

Paciente consulta con cuadro compatible con Profilaxis de Streptococcus agalactiae (SGB / Grupo B). Según el perfil EUNACOM, ¿cuál es la conducta de seguimiento más apropiada?

- A)** Alta sin controles dado que es una condición autolimitada
- B)** Derivación inmediata al especialista en todos los casos
- C)** Control según evolución clínica y criterios del perfil EUNACOM para esta patología
- D)** Hospitalización preventiva en todos los casos para monitorización
- E)** Tratamiento de por vida sin necesidad de controles periódicos

RESUMEN: PROFILAXIS DE STREPTOCOCCUS AGALACTIAE (SGB / GRUPO B)

:::note MINSAL Chile: Dar profilaxis si < 37 semanas aunque cultivo esté negativo. Guías internacionales: Cultivo negativo reciente → no es necesaria la profilaxis. ::: No requiere profilaxis para SGB (sin contacto vaginal), pero sí profilaxis de herida operatoria (que también cubre SGB con ampicilina).